



Processo TC nº 03.208/24

RELATÓRIO

Cuida o presente processo de REPRESENTAÇÃO, encaminhada a esse Tribunal pelo **Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Doutor Marcílio Toscano Franca Filho**, noticiando supostas irregularidades ocorridas no âmbito da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, no tocante ao quadro de cirurgiões pediátricos da rede Estadual de Saúde.

A Unidade Técnica, visando apurar os fatos denunciados, analisou a documentação e emitiu o RELATÓRIO INICIAL de fls. 73/84, constatando o seguinte:

O Representante do MPJTCE/PB afirmou que foi encaminhado ao Ministério Público junto ao TCE/PB, Ofício nº 506/2024, proveniente da Procuradoria da República na Paraíba dando conta do Inquérito Civil nº 1.24.000.000775/2016-63, cujo objeto se revela na apuração da situação do Quadro de Cirurgiões Pediátricos na rede estadual de Saúde.

Foi noticiado, no supracitado Inquérito Civil (anexo), situação de risco da falta de cirurgiões pediátricos na rede de atenção hospitalar estadual, que estaria sendo suprido por contratações precárias de alguns profissionais, os quais ameaçavam encerrar seus vínculos se não houvesse pagamento de remunerações mais elevadas.

Cabe frisar que, para uma carreira tão importante e com delicada funções na atenção pediátrica da rede hospitalar, sejam estabelecidos contratos de meros prestadores de serviços que, inclusive, podem encerrar seus vínculos a qualquer momento.

Saliente-se que há premente necessidade de regularização das contratações de cirurgiões pediátricos (caso não estejam, no momento, efetivamente regularizados) através das hipóteses constitucionalmente estabelecidas, mediante ingresso por meio de concurso público, com regime de trabalho e distribuição de cargas horárias dos referidos profissionais de modo satisfatório para o atendimento da demanda estadual, evitando-se deficiências e riscos de interrupção de serviços tão sensíveis

Em apertada síntese, o inquérito citado, encaminhado pelo Ministério Público Federal (fls. 5/15), visa apurar a situação do quadro de cirurgiões pediátricos no nosocômios estaduais de referência (Hospital Frei Damião, Instituto Cândida Vargas e Hospital Universitário Lauro Wanderley), um vez que restou constatada a situação de risco de escassez de cirurgiões pediátricos na rede estadual de saúde.

Os atuais integrantes dos quadros são proveniente de contratações precárias e ameaçam deixar suas funções em caso de não atendimento do pleito de aumento salarial.

Além deste conflito entre os profissionais e a rede de saúde, momentaneamente resolvido, de acordo com o inquérito, foi constatado que o quadro de profissionais atual não é suficiente para atender às demandas da rede saúde. Repisa-se, ainda, que o inquérito é de 2019 e, já na época da conclusão foi verificado que a rede estadual de saúde já estava encaminhando pacientes para atendimento em outros Estados, diante da falta imediata destes cirurgiões.

Ato contínuo, o inquérito menciona a expedição de ofícios à Controladoria-Geral do Estado da Paraíba e à Secretária Estadual de Saúde da Paraíba, requerendo esclarecimentos quanto aos fatos envoltos na questão central, tais como: medidas cabíveis para adequação do quadro de profissionais, análise do regime de trabalho atual destes profissionais, eventuais impedimentos de novas contratações, em face dos limites impostos pela LRF, funções exercidas pelos profissionais identificados como “codificado”, informações acerca de um concurso realizado previamente e se ele abrangeu o cargo de cirurgião pediátrico.



Processo TC nº 03.208/24

Ao analisar as respostas, o inquérito conclui pela insuficiência dos esclarecimentos e ações, até então verificadas, atestando, inclusive, a ausência de um plano de contingência pela SES/PB, em caso de falta destes profissionais. Agravando ainda mais a situação, verificou-se que a situação já vinha sendo acompanhada desde 2016, através de outro inquérito, porém, sem grandes avanços.

O inquérito ainda menciona uma manifestação genérica, no âmbito dos esclarecimentos da SES/PB, acerca da realização de um concurso pela recém criada FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE.

Isto posto, o inquérito conclui com a insuficiência das ações e esclarecimentos fornecidos até então, manifestando-se acerca de uma possível atuação do controle externo, “tendo em vista a dificuldade manifestada pelo controle interno do ente estadual em averiguar questão tão grave, sensível e urgente, envolvendo deficiências e riscos de interrupção de serviços de cirurgia pediátrica na rede hospitalar estadual pela falta de contratação de profissionais cirurgiões por vias regulares”.

Ato contínuo, após a Representação apresentada pelo Ministério Público de Contas, o D. Relator exarou despacho às fls. 17/18, determinando a apuração dos fatos, o qual a Auditoria passa a relatar.

Diante das informações iniciais contidas no Inquérito, a Auditoria realizou uma solicitação de documentos perante a SES/PB e a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde – PBSAÚDE, para entender o estado atual da situação, segregando a solicitação por nível de participação, da seguinte forma (fls. 19/20):

• SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE:

- 1 - Quantidade de profissionais contratados pelo Estado e a natureza dos respectivos vínculos;
- 2 – Disponibilidade dos profissionais entre as unidades de saúde do Estado;
- 3 – Informações acerca de um plano de contingência, em caso de insuficiência de profissionais;
- 4 – Status atual das medidas adotadas pelo Estado, em caso de insuficiência de profissionais;
- 5 – Número de pacientes transferidos para outros Estados, em virtude da impossibilidade de atendimento da demanda, pelo quadro de profissionais do Estado;
- 6 – Número de óbitos de neonatos que demandaram cirurgia pediátrica entre 2022 e 2024, caso haja;
- 7 – Informação acerca do status de eventual transferência de gestão das unidades de referência para a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde – PBSAÚDE, e eventual plano de regularização por parte da própria Fundação, tendo em vista a situação atual;
- 8 – Metas referentes a cirurgias pediátricas no âmbito da SES/PB e os respectivos resultados aferidos, no período de 2022 até o presente momento;
- 9 – Informações encaminhadas pela Secretaria no âmbito do Inquérito Civil nº 1.24.000.001066/2016-48, APENAS NO TOCANTE À SITUAÇÃO DOS CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS.

• FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PBSAÚDE:

- 1 - Considerando o Processo Seletivo nº 001/2022 realizado pela Fundação Paraibana em Gestão em Saúde - PBSAÚDE que, dentre as vagas disponíveis, disputa de 2 vagas para o cargo de médico - cirurgia pediátrica e 7 para cadastro reserva e considerando que, de acordo com o 1º edital de convocação, só houve uma classificada, esclarecer qual é o planejamento estratégico para o suprimento das necessidades cirúrgicas e como a demanda tem sido suprimida;
- 2 - Considerando que não há Contrato de Gestão em vigor, que tenha chegado ao conhecimento desta Corte de Contas, em relação ao Complexo Pediátrico Arlinda Marques, designada como Unidade de Referência, esclarecer a alocação da médica contratada, e a forma de atuação da Fundação no suprimento de demandas eventualmente reprimidas de hospitais sob gestão direta do Estado, no tocante à cirurgias pediátricas.



Processo TC nº 03.208/24

Ainda que não fosse necessário, a Auditoria deixou claro que, todos os pedidos baseiam-se em fatos pré-existentes, razão pela qual já deveria haver documentação pré-constituída para tanto, visto tratar-se de informações do dia a dia da Secretária e da Fundação.

Passado o prazo da solicitação, sem envio da documentação, os Gestores requereram dilação de prazo para apresentação dos documentos. Ainda que pré-existentes, fora concedido novo prazo, conforme certidão de fls. 25/26.

Novamente, mesmo requerendo a dilação probatória e tendo seu pleito atendido, o Gestor da SES/PB se manteve omissos no envio da documentação, configurando obstrução à atividade fiscalizatória. Contudo, 4 dias após o encerramento do prazo, o Gestor encaminhou esclarecimentos via requerimento, através do Documento TC nº 67577/24 (fls. 55/71).

Quanto ao Gestor da Fundação, este enviou a documentação requerida dentro do prazo requerido, através do Documento TC nº 67422/24 (fls. 34/53).

PB SAÚDE

Manifestação TCE nº 03208/24 (fls. 34/37)

Concernente ao primeiro ponto, o Gestor esclareceu que no que concerne ao Processo Seletivo realizado em 2022, houve apenas uma aprovada e convocada para o cargo de cirurgia pediátrica, mas que esta requereu desligamento no mesmo ano, em 06 de outubro de 2022.

Assim, desde então, a Fundação não possui cirurgiões pediátricos em seus quadros, por ausência de profissionais aprovados em concurso.

Quanto ao segundo questionamento, o Gestor apenas informou que a Fundação é integrante da Administração Indireta e que, para que esta possa atuar no suprimento de possível demanda estadual reprimida de cirurgias pediátricas, este serviço precisaria ser contratualizado.

Neste último questionamento, a resposta fugiu do contexto questionado. A pergunta se seu no sentido de entender onde a profissional contratada pela Fundação havia sido alocada, e se algum dos hospitais sob a atual gestão da Fundação prestava tais serviços. Contudo, havendo a informação do esvaziamento do quadro, face o pedido de desligamento pela profissional, entende-se que, ainda que houvesse tal prestação de serviço, ele estaria inacessível por ausência de médicos especializados.

SECRETÁRIA DE SAÚDE

- **Quantidade de profissionais contratados pelo Estado e a natureza dos respectivos vínculos;**
- **Disponibilidade dos profissionais entre as unidades de saúde do Estado.**

O Gestor juntou a lista dos médicos cirurgiões contratados. Segundo informações do Setor de Recursos Humanos da SES/PB, a jornada dos profissionais é de 24 horas semanais. Por fim, o Despacho do Setor informa que não há previsão para realização de concurso público para médicos no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 60/62).

Conforme a lista compartilhada (fls. 61), são 19 médicos cirurgiões pediátricos lotados na SES atualmente, conforme a seguinte distribuição:

• Hospital Infantil Arlinda Marques – 14 médicos

Considerando o plantão de 24 horas semanais e que a semana possui 7 dias, tem-se que, segundo as informações prestadas pela SES/PB, a UH conta com 2 médicos cirurgiões pediátricos por dia. Contudo, não foi encaminhada a escala dos médicos, de modo que não há absoluta certeza se a distribuição dos profissionais se dá da forma aqui disposta.



Processo TC nº 03.208/24

Bem como, não há informação sobre a suficiência quantitativo é suficiente para as demandas da Unidade.

- **Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena – 01 médico**
- **Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernanda – 03 médicos.**
- **Informações acerca de um plano de contingência, em caso de insuficiência de profissionais**

De acordo com os esclarecimentos do Gestor:

A rede estadual de saúde do estado da Paraíba é composta por quadro robusto e diverso – em todas as áreas.

No tocante aos cirurgiões pediátricos, a rede possui a especialidade nas três macrorregiões que o estado é dividido para melhor organização de planejamento na saúde. Em pensamento sobre um plano de contingência (pauta), informo-os que a rede estadual possui ainda a especialidade na modalidade “sobre aviso” no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires e também no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, além de escala com 2 (dois) plantonistas no regime presencial no Hospital de Trauma de Campina Grande – caso haja necessidade, garantindo o atendimento regular aos pacientes.

Apesar da robustez das alegações, nada foi devidamente comprovado com evidências que demonstrem a veracidade das alegações.

Conforme lista encaminhada, são apenas 19 médicos cirurgiões pediátricos para toda a rede estadual de saúde, médicos estes com plantões de 24 horas semanais, dos quais 63% possuem vínculos precários e frágeis. Inclusive, conforme consta do inquérito que subsidiou a presente representação, profissionais com vínculos desta natureza já se utilizaram da fragilidade dos vínculos para exigir aumento remuneratório, sob pena de abandono de cargo. Portanto, não há fundamento sólido que permita a conclusão pela robustez do quadro de médicos cirurgiões pediátricos.

Outra informação incondizente com a realidade fática é a de que “a rede possui a especialidade nas três macrorregiões [...]”. Conforme a lista encaminhada pelo próprio Gestor, os médicos estão alocados em apenas 3 hospitais, dos quais, dois se situam na capital, João Pessoa, e um se situa em Campina Grande. Estes municípios se situam na 1ª e 2ª macrorregiões da Saúde, conforme informações do COSEMSPB.

Sobre a eventual modalidade “sobre aviso”, não há nenhuma evidência fática que comprove tal alegação. Inclusive, o Despacho nº SES-DES-2024/65685 (fl. 60) detalha o plantão dos médicos e não menciona nenhuma hipótese da modalidade citada, bem como, não foi apresentado nenhum contrato com profissionais que mencione tal situação.

Portanto, a dedução lógica, leva à conclusão de que não há um plano de contingência para o caso de insuficiência de profissionais, aumentando consideravelmente os riscos para as famílias dependentes do Serviço Público.

- **Status atual das medidas adotadas pelo Estado, em caso de insuficiência de Profissionais**

Conforme esclarecimentos do Gestor:

O Estado se mostra disposto e em busca ativa para mais contratações desta especialidade (seja no estado da Paraíba, como também em outros estados da federação). No presente momento estamos em construção de um estudo técnico preliminar e Edital de chamamento público para contratação do serviço por meio de Pessoa Jurídica de direito privado, com fins de ampliar o atendimento dessa especialidade.



Processo TC nº 03.208/24

Novamente aqui, os argumentos não encontram amparo na realidade fática e são amplamente incondizentes com as próprias evidências trazidas nos autos.

Conforme o exposto no Despacho nº SES-DES-2024/65685 (fl. 60), “NÃO HÁ PREVISÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA MÉDICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE”.

Além disso, conforme conclusão anterior, não há evidências de que haja efetivamente um plano de contingência em vigor.

• Número de pacientes transferidos para outros Estados, em virtude da impossibilidade de atendimento da demanda, pelo quadro de profissionais do Estado

O Gestor apresentou os seguintes números:

2022 – 350 pacientes transferidos para outros Estados;
2023 – 280 pacientes transferidos para outros Estados;
2024 – 30 pacientes transferidos para outros Estados;

Como os resultados não foram apresentados mês a mês, não há como determinar se 2024 representa uma queda expressiva no número de transferências, ou se estas transferências sejam uma questão sazonal. Demais disso, o Gestor não apresentou a fonte da informação e nem onde seria possível acessá-la.

Conquanto, resta claro que a rede estadual de saúde não possui a robustez alegada pelo Gestor, tendo em vista o elevado número de pacientes transferidos a outros Estados.

Por fim, em função da ausência de um plano de contingência ou de um estudo de caso apresentado pelo Gestor, não se pode concluir que a redução entre 2022 e 2023 tenha sido resultado de um planejamento, ou ocasionada por uma sazonalidade da demanda.

• Número de óbitos de neonatos que demandaram cirurgia pediátrica entre 2022 e 2024, caso haja

Quanto a este ponto, o Gestor apresentou informações do SIM – Sistema de informação sobre Mortalidade, junto aos seguintes argumentos:

Abaixo seguem os registros de óbitos de neonatos entre 2022 a 2024, constantes do sistema de informação sobre mortalidade (SIM), esclarecendo que tais óbitos decorreram de fatores diversos, e não em face de ausência de atendimento, vez que tais pacientes possuem prioridade de atendimento, através das medidas do “leito zero”, em que aplicam medida de urgência as unidades referenciadas, independente da lotação da unidade hospitalar.

[...]

Dessa forma, através do sistema de vaga zero, quando o recém-nascido tem um caso grave, o Estado encaminha para o atendimento hospitalar, garantindo o atendimento regular aos pacientes.

Sendo assim, o Gestor não apresentou os documentos solicitados pela Auditoria, que eram referentes apenas aos pacientes que demandaram cirurgia pediátrica, demonstrando desconhecimento desta informação, razão pela qual foram utilizados dados de uma base geral e que não indicam qualquer redução significativa no número de óbitos, sempre variando numa faixa muito próxima, por fatores que o Gestor sequer explicou.

• Informação acerca do status de eventual transferência de gestão das unidades de referência para a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde – PBSAÚDE, e eventual plano de regularização por parte da própria Fundação, tendo em vista a situação atual.



Processo TC nº 03.208/24

Neste tema o Gestor informou que não há, a curto e médio prazo, um cronograma de contratualizações entre a SES/PB e PB SAÚDE, para gestão das unidades de referência.

Neste ponto, como não há mais uma profissional especializada no âmbito da Fundação, tal questionamento não possui mais eficácia prática.

• Metas referentes a cirurgias pediátricas no âmbito da SES/PB e os respectivos resultados aferidos, no período de 2022 até o presente momento

Neste item, o Gestor apresentou os seguintes esclarecimentos:

A Gerência Executiva de Regulação e Avaliação da Assistência (GERAV) tem como função a inserção do paciente que necessita de cirurgia pediátrica de urgência no serviço de referência. Levando em consideração que foi implementado no estado da Paraíba o serviço de regulação de urgência e regulação de leitos com todas as linhas de cuidado e de todas as macrorregiões de saúde apenas no mês de janeiro do presente ano.

Cientificando que a GERAV acompanha as regulações de urgência que demandam cirurgia pediátrica:

Na 1ª macrorregião de saúde, no ano de 2024 até a presente data que este ofício está sendo respondido, tivemos 182 solicitações de urgência que demandaram de cirurgia pediátrica. Destas 182 solicitações, 171 tiveram a solicitação aprovada e 11 foram categorizados como evasão/alta hospitalar. Com isso, no ano de 2024 tivemos 93,95% de aprovação das solicitações que demandam cirurgia pediátrica na urgência.

Ainda ofertando alguns dados para título de conhecimento e provar que as metas de qualificação estão sendo cumpridas, informo-os que na 2ª macrorregião de saúde, no ano de 2024, tivemos 607 solicitações de avaliação de urgência que, a princípio, solicitaram cirurgia pediátrica. Destas, 577 foram aprovadas para avaliação presencial do cirurgião pediátrico e 30 foram rotuladas como evasão/alta hospitalar/falta de necessidade após avaliação do cirurgião de forma remota. Com isto, informo uma taxa de 90,05% de aprovação da avaliação presencial com o cirurgião pediátrico.

Ratifico aqui ainda que em nenhuma das solicitações que chegou à Central de Regulação Estadual (CRE), que demandaram urgência e uma abordagem da cirurgia pediátrica, teve negativa por falta de profissional na rede estadual de saúde.

A solicitação recaia sobre as metas de cirurgias pediátricas, no sentido de quantitativo de profissionais x nº de cirurgias possíveis, estudo histórico do quantitativo de cirurgias pediátricas anuais, adequação da demanda à disponibilidade de médicos, indicadores de sucesso das cirurgias realizadas, dentre outros.

O que o Gestor demonstrou foi apenas a quantidade de solicitações aprovadas na 1ª macrorregião e o número de solicitações aprovadas, para avaliação presencial, na 2ª macrorregião e nenhuma informação quanto à 3ª macrorregião.

As informações concedidas, além de rasas, não permitem concluir se as cirurgias sequer foram realizadas, já que a aprovação alegada era referente à avaliações presenciais, bem como, não demonstra a taxa de sucesso das cirurgias por ventura realizadas.

Ante o exposto, a Auditoria conclui pela instabilidade da situação dos médicos cirurgiões pediátricos na rede estadual de saúde paraibana, representando riscos significativos às famílias atendidas, pelos seguintes motivos:



Processo TC nº 03.208/24

Estado;

- Não há demonstração de que o quadro de profissionais seja suficiente para as demandas do Estado;
- Dos profissionais contratados, 63% possuem vínculo precário;
- Não há previsão de um novo concurso;
- Não há um plano de contingência para demandas não supridas pelo estado;
- O Titular da pasta demonstrou pouco ou nenhum conhecimento sobre a questão, tendo em vista que as próprias alegações foram incondizentes com as evidências apresentadas;
- Não há um plano de meta acerca das cirurgias pediátricas;
- Não existem dados que determinem a quantidade e o sucesso das cirurgias realizadas;
- A terceira macrorregião de saúde da Paraíba se encontra totalmente desassistida de médicos cirurgiões pediátricos.

Quanto à PBSAÚDE, o gestor apresentou esclarecimentos que evidenciam que a Fundação não possui sob a sua gestão qualquer unidade hospitalar de referência, bem como, o desligamento da médica contratada para tal especialidade.

Ainda que tenha enviado a documentação, esta Auditoria entende que o Gestor da SES/PB incorreu em obstrução à atividade fiscalizatória, visto que não observou aos prazos concedidos por esta Corte de Contas, mesmo após dilação requerida pelo próprio.

Em que pese a análise desta Corte de Contas se dê com base na busca da verdade real, a função precípua deste Areópago possua natureza fiscalizatória e instrutiva, também há o caráter punitivo, no sentido de ressarcir danos ao erário e reprimir condutas que sejam incondizentes com o múnus público. Neste caso, práticas de desobediência às determinações desta Corte de Contas, além de causar danos ao erário, visto provocarem um retrabalho por parte da Equipe Técnica desta Corte de Contas, cujos custos são arcados pela sociedade, subjugam a autonomia da corte. Portanto, a Auditoria sugere a imputação de multa, nos termos do art. 56, incisos IV e V da Lei Orgânica desta Corte de Contas.

Por fim, a Auditoria ressalta que, quando do início da presente análise o Sr. Arimatheus Silva Reis ocupava o cargo de Gestor da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde-PB Saúde, no entanto, conforme Ato Governamental nº 1613, de 12 de junho de 2024, ele passou a ocupar o cargo de Secretário de Estado da Saúde.

Posto isto, a Auditoria sugere que o Gestor seja citado, também, enquanto Secretário de Saúde, para que tome conhecimento da demanda, nesta condição.

Em seguida, houve a citação dos Gestores, à época, da Secretaria de Estado da Saúde, **Sr. Jhony Wesllys Bezerra Costa**, bem como do **Sr. Arimatheus Silva Reis**, da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PBSaúde, para se pronunciarem sobre o Relatório Técnico do Auditoria.

o ex-Secretário de Estado da Saúde, Sr. Jhony Wesllys Bezerra Costa, bem como o atual Secretário da Saúde, Sr. Arimatheus Silva Reis, apresentaram DEFESAS neste Tribunal, conforme Documentos TC nº 96179/24 e nº 132195/24.

Do exame da documentação apresentada pelos Secretários de Estado da Saúde (ex e atual), a Unidade Técnica emitiu os **Relatórios de Análise de Defesa** de fls. 128/144 e 231/240, com as seguintes considerações:

Após a análise das defesas apresentadas pelos Secretários de Estado da Saúde, bem como das informações/documentações carreadas aos autos, a Unidade Técnica concluiu no sentido da instabilidade da situação dos médicos cirurgiões pediátricos na rede estadual de saúde paraibana, representando riscos significativos às famílias atendidas, pelo seguintes motivos:

- Não há demonstração de que o quadro de profissionais seja suficiente para as demandas do Estado;
- Dos profissionais contratados, 63% possuem vínculo precário;



Processo TC nº 03.208/24

- Não há previsão de um novo concurso;
- Não há um plano de contingência para demandas não supridas pelo estado;
- O Titular da pasta demonstrou pouco ou nenhum conhecimento sobre a questão, tendo em vista que as próprias alegações foram incondizentes com as evidências apresentadas;
- Não há um plano de meta acerca das cirurgias pediátricas;
- Não existem dados que determinem a quantidade e o sucesso das cirurgias realizadas;
- A terceira macrorregião de saúde da Paraíba se encontra totalmente desassistida de médicos cirurgiões pediátricos.

Após o exame da defesa apresentada, a Auditoria conclui que o Gestor não apresentou justificativa plausível e devidamente evidenciada para a contratação de profissionais médicos por credenciamento como via principal, em desconformidade com a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) e em confronto com o art. 37, II da CF, uma vez que não restou devidamente comprovado se tratar de uma contratação complementar ou temporária, ou ainda estar dentro do planejamento da pasta como parte do escopo de eventual plano de contingência, que não foi apresentado.

Por fim, destaca-se que, apesar de se tratar de um edital de chama pública de 2024, o certame não foi devidamente protocolado junto a esta Corte de Contas.

Ao se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público junto ao Tribunal, através do Douto Procurador **Manoel Antônio dos Santos Neto**, emitiu o Parecer nº 0094/2025, às fls. 243/249, ressaltando os seguintes aspectos:

O presente processo foi autuado em virtude de Representação protocolada pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Marcílio Toscano da Franca Filho, com a finalidade de avaliar a situação do quadro de cirurgiões pediátricos no âmbito da rede hospitalar estadual, e a eventual previsão de concurso público para tais cargos.

Vê-se, pois, que se trata de uma reiteração de um pedido feito anteriormente, na qual a resposta deste Ministério Público de Contas, através do ofício 008/2023 – PROGE/MPC-PB “não constou referência ao tema veiculado naquele expediente, mas sim outras irregularidades”.

O expediente em referência é o Ofício nº 4417/2021/MPF/PRPB/JGFC (fls. 7/14), no qual evoca preocupações a respeito da natureza dos vínculos dos cirurgiões pediátricos, bem como o cumprimento de sua carga horária, sua adequabilidade/compatibilidade de produtividade, e, enfim, a falta de profissionais desta especialidade na estrutura da saúde estadual.

Ato contínuo, a certidão publicada no Diário Oficial Eletrônico (Edição nº 3417) foi no seguinte sentido (cf. fls. 19/20):

Solicitação de Envio de Documentação:

Considerando Representação apresentada pelo Ministério Público de contas, acerca da situação do quadro de cirurgiões pediátricos no âmbito da saúde estadual, a Auditoria requer ao Sr. Jhony Wesllys Bezerra Costa, Secretário Estadual de Saúde a seguinte documentação em relação a tais profissionais:

- 1 - Quantidade de profissionais contratados pelo Estado e a natureza dos respectivos vínculos;
- 2 - Disponibilidade dos profissionais entre as unidades de saúde do Estado;
- 3 - Informações acerca de um plano de contingência, em caso de insuficiência de profissionais;
- 4 - Status atual das medidas adotadas pelo Estado, em caso de insuficiência de profissionais;
- 5 - Número de pacientes transferidos para outros Estados, em virtude da impossibilidade de atendimento da demanda, pelo quadro de profissionais do Estado;
- 6 - Número de óbitos de neonatos que demandaram cirurgia pediátrica entre 2022 e 2024, caso haja;
- 7 - Informação acerca do status de eventual transferência de gestão das unidades de referência para a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde PBSAÚDE, e eventual plano de regularização por parte da própria Fundação, tendo em vista a situação atual;



Processo TC nº 03.208/24

8 - Metas referentes a cirurgias pediátricas no âmbito da SES/PB e os respectivos resultados aferidos, no período de 2022 até o presente momento;

9 - Informações encaminhadas pela Secretaria no âmbito do Inquérito Civil nº 1.24.000.001066/2016-48, APENAS NO TOCANTE À SITUAÇÃO DOS CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS.

Salienta-se que o requerimento recai, principalmente, sobre a existência de informações complementares aos esclarecimentos já prestados no âmbito do inquérito civil supracitado, tendo em vista que, em que pese os esclarecimentos no âmbito do processo mencionado, estas foram consideradas insuficientes/evasivas, pelas autoridades responsáveis.

Outrossim, requer-se ao Sr. Arimatheus Silva Reis, Superintendente da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde PBSAÚDE as seguintes informações acerca do Processo Seletivo nº 001/2022:

1 - Considerando o Processo Seletivo 001/2022 realizado pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PBSAÚDE que, dentre as vagas disponíveis, dispunha de 2 vagas para o cargo de médico cirurgia pediátrica e 7 para cadastro reserva e considerando que, de acordo com o 1º edital de convocação, só houve uma classificada, esclarecer qual é o planejamento estratégico para o suprimento das necessidades cirúrgicas e como a demanda tem sido suprida;

2 - Considerando que não há contrato de gestão em vigor, que tenha chegado ao conhecimento desta Corte de Contas, em relação ao Complexo Pediátrico Arlinda Marques, designada como unidade de referência, esclarecer a alocação da médica contratada, e a forma de atuação da Fundação no suprimento de demandas eventualmente reprimidas de hospitais sob gestão direta do Estado, no tocante à cirurgias pediátricas.

A solicitação compreende as questões que necessitam de esclarecimentos.

Tendo ocorrido a convocação regular e em contraditório do gestor – registrando-se também a confecção de 3 relatórios por parte do órgão técnico de instrução –, a derradeira manifestação técnica concluiu pela manutenção das considerações insertas nos relatórios anteriores, *in verbis*:

Ante o exposto, restam mantidas as considerações finais, insertas no Relatório anterior, quais sejam:

[...] conclui pela instabilidade da situação dos médicos cirurgiões pediátricos na rede estadual de saúde paraibana, representando riscos significativos às famílias atendidas, pelos seguintes motivos:

- *Não há demonstração de que o quadro de profissionais seja suficiente para as demandas do Estado;*
- *Dos profissionais contratados, 63% possuem vínculo precário;*
- *Não há previsão de um novo concurso;*
- *Não há um plano de contingência para demandas não supridas pelo estado;*
- *O Titular da pasta demonstrou pouco ou nenhum conhecimento sobre a questão, tendo em vista que as próprias alegações foram incondizentes com as evidências apresentadas;*
- *Não há um plano de meta acerca das cirurgias pediátricas;*
- *Não existem dados que determinem a quantidade e o sucesso das cirurgias realizadas;*
- *A terceira macrorregião de saúde da Paraíba se encontra totalmente desassistida de médicos cirurgiões pediátricos.*



Processo TC nº 03.208/24

Após o exame da defesa apresentada, esta Auditoria conclui que o Gestor não apresentou justificativa plausível e devidamente evidenciada para a contratação de profissionais médicos por credenciamento como via principal, em desconformidade com a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) e em confronto com o art. 37, II da CF, uma vez que não restou devidamente comprovado se tratar de uma contratação complementar ou temporária, ou ainda estar dentro do planejamento da pasta como parte do escopo de eventual plano de contingência, que não foi apresentado.

Por fim, destaca-se que, apesar de se tratar de um edital de chama pública de 2024, o certame não foi devidamente protocolado junto a esta Corte de Contas.

Ainda que seja bem comum nos processos dessa natureza que as questões fulcrais acabem se espraiando por outros temas correlatos que refogem à demanda, no caso em apreço, a auditoria foi capaz de focar a fiscalização aos temas que desencadearam a representação.

Vislumbra-se que, no tocante à quantidade de profissionais contratados pelo Estado e a natureza dos respectivos vínculos, apurou-se que existem apenas 19 médicos cirurgiões pediátricos para toda a rede estadual de saúde, médicos estes com plantões de 24 horas semanais, dos quais 63% possuem vínculos precários e frágeis.

Isso por si só demonstra que o quadro de profissionais é insuficiente para as demandas do Estado. Se não bastasse, tal conclusão fica ainda mais patente ao se constatar que terceira macrorregião de saúde da Paraíba encontra-se totalmente desassistida de médicos cirurgiões pediátricos.

No que tange ainda ao cumprimento de carga horária dos cirurgiões pediátricos existentes, e sua adequabilidade/compatibilidade de produtividade, concluiu-se que não há um plano de metas acerca das cirurgias pediátricas e que não existem dados que determinem a quantidade e o sucesso das cirurgias realizadas. Foram requeridos dados sobre metas de cirurgias pediátricas, cotejando o quantitativo de profissionais e o número de cirurgias possíveis, estudo histórico do quantitativo de cirurgias pediátricas anuais, adequação da demanda à disponibilidade de médicos, indicadores de sucesso das cirurgias realizadas, dentre outros, porém, as informações concedidas, além de rasas, não permitiram concluir se as cirurgias sequer foram realizadas, já que a aprovação alegada era referente à avaliações presenciais, bem como não demonstra a taxa de sucesso das cirurgias por ventura realizadas.

Por fim, destacou-se a notícia de que há edital de chamamento público de 2024 para contratação do serviço por meio de Pessoa Jurídica de direito privado, com fins de ampliar o atendimento dessa especialidade. Contraditoriamente, não há previsão de um novo concurso.

Ora, há a necessidade de prévia comprovação da insuficiência da rede pública e a impossibilidade de ampliação dos serviços próprios como condição para contratar serviços da iniciativa privada. Ou seja: a atuação complementar da iniciativa privada no SUS somente será legítima se houver insuficiência da rede pública e impossibilidade de ampliação dos serviços próprios pelo ente público. Se a insuficiência da rede for em razão da negligência ou recusa do ente público em adequar sua estrutura à demanda existente, a complementação pela iniciativa privada poderá ser tida como irregular, inclusive com possibilidade de responsabilização do gestor recalcitrante.

Considerando o caráter finalístico e a titularidade dos serviços públicos de saúde, o credenciamento não se destina à substituição do quadro de pessoal próprio, mas à complementação dos serviços prestados diretamente.

Para efetivação do credenciamento, deve-se demonstrar que existem ações no sentido de não perpetuar a excepcionalidade, devendo ser planejado e realizado concurso público.

Portanto, embora a contratação de profissionais de saúde para atuar de forma complementar ao SUS seja legalmente amparada, tal medida somente será legítima se a contratação por credenciamento esteja sendo tomada como medida de exceção, e somente enquanto não se deflagra outro concurso.

Processo TC nº 03.208/24

ANTE O EXPOSTO, o Representante do Ministério Público de junto ao Tribunal de Contas pugnou pela:

1. ASSINAÇÃO DE PRAZO para que promova o recrutamento de cirurgiões pediátricos por meio de concurso público, com notificação do Chefe do Poder Executivo e do Secretário da Pasta para providências que entender cabíveis, no que tange a eventual criação de cargos públicos, caso inexistentes ou insficientes;

2. TRANSLADO de INFORMAÇÕES acerca da situação atual do Quadro de Profissionais precários à PCA da Secretaria de Estado da Saúde;

3. NOTIFICAÇÃO à Procuradoria da República acerca das conclusões do presente processo.

É o relatório! Informando que os Interessados foram intimados para a presente sessão!

VOTO

Considerando as conclusões a que chegou o Órgão de Instrução, bem como o parecer oferecido pelo Ministério Público Especial, VOTO para que os membros da Egrégia **1ª Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**:

- 1) ENCAMINHEM o ENVIO do link dos presentes autos ao Processo de Acompanhamento da Gestão da Secretaria de Estado da Saúde, para fins de subsidiar a análise da Gestão da Secretaria, exercício financeiro de 2025;
- 2) RECOMENDEM aos atuais Gestores da Secretaria de Estado da Saúde, **Sr. Arimatheus Silva Reis**, e da PB SAÚDE, **Sr. Jhony Welllys Bezerra Costa**, para que enviem esforços no sentido da regularização, o mais breve possível, do quadro de cirurgiões pediátricos da rede estadual de saúde, de modo a permitir a satisfação do melhor atendimento à população paraibana, seguindo as orientações da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) e as recomendações do Ministério Público Federal, sob pena de repercussão negativa na análise das prestações de contas futuras da Secretaria de Estado da Saúde;
- 3) ENCAMINHEM comunicação desta decisão à Procuradoria da República na Paraíba.

É o Voto !

Antônio Gomes Vieira Filho
Conselheiro - Relator



1ª Câmara

Processo TC nº 03.208/24

Objeto: REPRESENTAÇÃO

Órgão: Secretaria de Estado da Saúde - SES/PB

Gestores Responsáveis: Arimatheus Silva Reis (Secretário de Saúde)

Jhony Welllys Bezerra Costa (Superintendente da PBSAÚDE)

Patronos/Procuradores: não consta

Denúncia contra atos da SES noticiando supostas irregularidades ocorridas, no tocante ao Quadro de cirurgições pediátricos da rede Estadual de Saúde.

ACÓRDÃO AC1 - TC nº 0816/2025

Vistos, relatados e discutidos os autos do **Processo TC nº 03.208/24**, que trata de **REPRESENTAÇÃO**, encaminhada a esse Tribunal pelo **Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Doutor Marcílio Toscano Franca Filho**, noticiando supostas irregularidades ocorridas no âmbito da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**, no tocante ao quadro de cirurgições pediátricos da rede Estadual de Saúde, **ACORDAM** os membros da Egrégia **1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**, à unanimidade de votos, em sessão plenária realizada nesta data, na conformidade do relatório, do Parecer Ministerial e do Voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em:

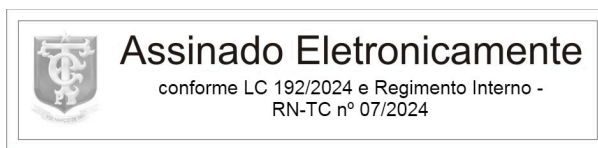
- 1) **ENCAMINHAR** o ENVIO do *link* dos presentes autos ao Processo de Acompanhamento da Gestão da Secretaria de Estado da Saúde, para fins de subsidiar a análise da Gestão da Secretaria, exercício financeiro de 2025;
- 2) **RECOMENDAR** aos atuais Gestores da Secretaria de Estado da Saúde, **Sr. Arimatheus Silva Reis**, e da PB SAÚDE, **Sr. Jhony Welllys Bezerra Costa**, para que envidem esforços no sentido da regularização, o mais breve possível, do quadro de cirurgições pediátricos da rede estadual de saúde, de modo a permitir a satisfação do melhor atendimento à população paraibana, seguindo as orientações da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) e as recomendações do Ministério Público Federal, sob pena de repercussão negativa na análise das prestações de contas futuras da Secretaria de Estado da Saúde;
- 3) **ENCAMINHAR** comunicação desta decisão à Procuradoria da República na Paraíba.

Presente ao Julgamento Representante do Ministério Público.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

TC- Sala das Sessões da 1ª Câmara, João Pessoa, 08 de maio de 2025.

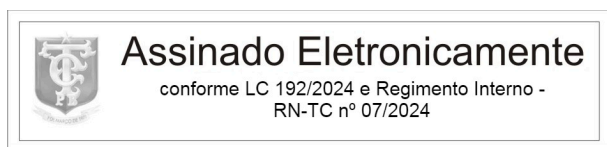
Assinado 15 de Maio de 2025 às 12:52



Cons. Antonio Gomes Vieira Filho

PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 15 de Maio de 2025 às 15:50



Elvira Samara Pereira de Oliveira

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO